

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE RESPUESTAS RUMIATIVAS (RRS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación del Estilo de Respuesta Rumiativa y Diferenciación Brooding / Reflection

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Respuestas Rumiativas (RRS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Ruminative Responses Scale (RRS)</i>
Autores Originales	Dras. Susan Nolen-Hoeksema y J. Morrow (1991); revisión de Treynor et al. (2003).
Adaptación Española	Daniel Hervás (2008); validación de Hervás y Vázquez (2006), Universidad Complutense de Madrid.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Teoría de los Estilos de Respuesta (Response Styles Theory).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 22 reactivos con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 13 años). Aplicación en psicoterapia, psiquiatría y neuropsicología.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración; 6 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento de uso libre con fines clínicos y de investigación académica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA RUMIACIÓN

La RRS es el instrumento paradigmático desarrollado bajo la **Teoría de los Estilos de Respuesta** formulada por Susan Nolen-Hoeksema. Define la rumiación como una forma de respuesta repetitiva, circular y pasiva ante el afecto disfórico, centrada persistentemente en los propios síntomas de malestar y en sus posibles causas y consecuencias, sin poner en marcha conductas activas de resolución.

Desde una perspectiva neurobiológica, la rumiación refleja una hiperconectividad patológica y rigidez funcional de la Red por Defecto (DMN: corteza prefrontal ventromedial, cíngulo posterior y precúneo), combinada con una incapacidad de la Red de Control Ejecutivo Frontoparietal para desconectar el foco atencional del material autorreferencial negativo. La revisión de Treynor et al. (2003) resolvió el solapamiento con los síntomas afectivos separando dos factores esenciales: la **Rumiación Reproche (Brooding)**, motor maladaptativo que perpetúa la depresión y dispara el riesgo autolítico; y la **Reflexión (Reflection)**, focalización introspectiva potencialmente adaptativa.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor de Rumiación	Ítems	Rango	Definición Operativa y Fenomenológica
1. Rumiación Reproche (Brooding)	5, 10, 13, 15, 16	5 a 20	Comparación pasiva e insistente de la situación actual con estándares no alcanzados, queja estéril y autorreproche culpabilizador.
2. Reflexión Adaptativa (Reflection)	7, 11, 12, 20, 21	5 a 20	Tendencia a analizar la propia mente y conducta con propósito de comprensión personal y búsqueda de perspectivas cognitivas.
3. Síntomas Depresivos Vinculados	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 22	12 a 48	Focalización atencional directa en el agotamiento físico, la tristeza, la falta de motivación y los déficits cognitivos del estado depresivo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en España: alfa de Cronbach de 0.93 para la escala total de 22 ítems, 0.79 a 0.82 para Brooding y 0.78 a 0.81 para Reflection (Hervás, 2008).
Estructura Limpia	Bifactorial El modelo de dos factores independientes de Treynor (Brooding y Reflection) muestra un ajuste óptimo mediante AFC (CFI = 0.96, RMSEA = 0.048), eliminando la contaminación sintomática con la depresión.
Validez Concurrente y Predictiva	Brooding predice con gran potencia la gravedad depresiva (BDI-II, $r = 0.65$), desesperanza (BHS, $r = 0.58$) y mayor duración de los episodios afectivos. Reflection correlaciona de modo moderado con resolución de problemas y no incrementa el riesgo depresivo longitudinal.
Sensibilidad al Cambio	Altamente sensible a terapias cognitivas basadas en mindfulness (MBCT) y TCC enfocada en rumiación (Rumination-focused CBT de Watkins), mostrando descensos específicos en Brooding ($d > 0.80$).
Invarianza Demográfica	Invarianza de medida ratificada entre varones y mujeres, revelando puntuaciones medias significativamente más altas en rumiación en la población femenina.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los reactivos se responde de 1 a 4 (1 = «Casi nunca», 2 = «A veces», 3 = «A menudo», 4 = «Casi siempre»):

- **Puntuación de Brooding (Rumiación Reproche):** Suma de los ítems **5 + 10 + 13 + 15 + 16** (Rango: **5 a 20 puntos**). Es el índice patológico primario.
- **Puntuación de Reflection (Reflexión):** Suma de los ítems **7 + 11 + 12 + 20 + 21** (Rango: **5 a 20 puntos**).
- **Puntuación Total RRS-22:** Suma de los 22 ítems (Rango: **22 a 88 puntos**). No contiene reactivos invertidos.
- **Norma de Cálculo Clínico:** En la práctica clínica basada en procesos, la subescala **Brooding** debe priorizarse analíticamente por encima de la puntuación total agregada.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (SUBESCALA BROODING)

Nivel Brooding	Puntuación	Perfil de Afrontamiento	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Adaptativo	5 a 9	Baja rumiación pasiva reprochadora	Capacidad adecuada para soltar pensamientos circulares y buscar distracciones o soluciones activas.
Moderado	10 a 12	Tendencia a la rumiación ante el estrés	Vulnerabilidad a entraparse en pensamientos de “¿por qué a mí?”. Psicoeducación en activación conductual.
Elevado	13 a 15	Rumiación clínica destructiva (≥ 13)	Perpetuación de estados depresivos y anhedonia. Indicación de TCC centrada en rumiación o terapia de tercera ola.
Severo / Extremo	16 a 20	Rumiación severa invalidante	Parálisis conductual completa, autorreproche implacable y riesgo elevado de cronificación y desesperanza.

VALOR PRONÓSTICO DE BROODING ≥ 13 PUNTOS (Hervás, 2008):

Una puntuación en **Brooding ≥ 13** cuadruplica el riesgo de recaída depresiva en pacientes remitidos y bloquea la eficacia de las tareas para casa entre sesiones. El clínico no debe intentar reestructurar el contenido del reproche mientras el paciente se mantenga en “modo rumiador”, sino cambiar primero el proceso a un modo de experiencia concreta.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DESACTIVACIÓN DE RUMIACIÓN

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL MODELO RFCBT (WATKINS):

- **Paso 1: Detección Temprana de Señales de Rumiación:** Identificar señales corporales y verbales del “modo por qué” abstracto (¿Por qué siempre fallo?, ¿Por qué no me esfuerzo más?).
- **Paso 2: Cambio de Modo Procesual:** Entrenar la transición del “Modo Evaluativo / Abstracto” al “Modo Concreto / Específico” (¿Cómo ocurrió exactamente?, ¿Qué paso conductual puedo dar ahora mismo?).
- **Paso 3: Absorción Sensorial y Flujo (Flow):** Programar actividades incompatibles que demanden atención focalizada y absorción sensorial directa (ej. ejercicio físico intenso, pintura, música).
- **Paso 4: Monitorización MBC:** Una disminución en Brooding de **>= 4 puntos** a la 6ª semana predice respuesta favorable y previene recaídas a largo plazo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN MAYOR RECIDIVANTE

Paciente: Varón de 39 años, abogado corporativo, que consulta por tercer episodio depresivo mayor en 5 años. Pese a encontrarse bajo tratamiento con Escitalopram 20 mg/día, refiere que pasa entre 3 y 5 horas acostado en el sofá rumiando sobre sus fallos profesionales pasados y anticipando su ruina.

Evaluación Cuantitativa Inicial: RRS Total = **68 puntos**; Brooding = **18 / 20 puntos** (Extremo; percentil 98); Reflection = **8 / 20 puntos**.

• **Reactivos Críticos:** Ítem 5 = 4 («Pienso en lo pasivo y desmotivado que me siento»); Ítem 10 = 4 («¿Por qué siempre reacciono de este modo?»); Ítem 13 = 4 («Pienso en una situación reciente y desearía que hubiera ido mejor»); Ítem 15 = 3; Ítem 16 = 3 («¿Por qué tengo problemas que los demás no tienen?»).

Formulación Clínica: La rumiación en forma de reproche (Brooding) constituye el mecanismo causal nuclear que mantiene encendido el episodio depresivo e inhibe la recuperación funcional.

Tratamiento y Evolución: Se implementó TCC Focalizada en Rumiación (RFCBT): análisis funcional de los antecedentes de la rumiación, entrenamiento en pensamiento concreto basado en procesos y práctica diaria de mindfulness de sonidos y respiración. Al cabo de 8 semanas, Brooding se redujo a **8 puntos** (descenso de 10 puntos), recuperando el horario laboral activo y eliminando los bloqueos por autoanálisis destructivo.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA: BROODING SEVERO Y RIESGO AUTOLÍTICO

Puntuaciones de Brooding ≥ 16 con puntuaciones altas en desesperanza multiplican por 5 el riesgo de paso al acto suicida. La rumiación agota los recursos cognitivos y transforma la idea de muerte en una aparente solución de escape definitivo.

TRAMPA DE LA INTROSPECCIÓN EN CONSULTA

Evitar sesiones prolongadas de exploración psicodinámica o discusión filosófica en pacientes con Brooding alto; el paciente convertirá la propia terapia en un nuevo vehículo de rumiación intelectualizada estéril.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(1), 115–121.
2. Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. *Cognitive Therapy and Research*, 27(3), 247–259.
3. Hervás, G. (2008). Adaptación al castellano de un instrumento para evaluar estilo rumiativo: la Escala de Respuestas Rumiativas. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 13(2), 111–121.
4. Watkins, E. R. (2016). *Rumination-focused cognitive-behavioral therapy for depression*. Guilford Publications.